

Trauma abdominal (lesión hepática, esplénica, intestinal, diafragmática)

1. Introducción y relevancia clínica

El **trauma abdominal** constituye entre el **15–20% de todos los traumas graves**, y es responsable de una proporción significativa de muertes **potencialmente prevenibles** si se reconoce y trata oportunamente.

Las lesiones más frecuentes son:

- **Hígado y bazo (trauma cerrado).**
- **Intestino delgado y colon (trauma penetrante).**
- **Diafragma (trauma toracoabdominal).**

El desafío clínico radica en que **los signos abdominales pueden ser sutiles o tardíos**, y el retraso en el diagnóstico se asocia a un **aumento de la mortalidad**.

□ En el **EUNACOM**, este tema suele presentarse como:

- Paciente politraumatizado hipotenso con abdomen distendido.
- Interpretación del **ecografía FAST o TAC de abdomen**.
- Decisión entre **manejo conservador o laparotomía exploradora**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo de trauma

El tipo de lesión depende del mecanismo:

- **Trauma cerrado:** por accidentes vehiculares, caídas o golpes directos.
 - Lesiones viscerales por **compresión o desaceleración**.
 - Hígado y bazo son los órganos más afectados.
- **Trauma penetrante:** por heridas de bala o arma blanca.

→ Lesiones de vísceras huecas (intestino, estómago) y macizas.

2.2. Tipos de hemorragia intraabdominal

- **Hemoperitoneo:** sangre libre en cavidad peritoneal (rotura de bazo o hígado).
- **Hemoperitoneo retroperitoneal:** por lesión renal o de grandes vasos.
- **Hemotórax abdominal (rotura diafragmática):** comunicación toracoabdominal.

2.3. Respuesta fisiológica

La pérdida de volumen intravascular produce **shock hipovolémico**, con taquicardia, hipotensión y vasoconstricción periférica.

La **isquemia visceral** agrava la permeabilidad intestinal → sepsis y falla multiorgánica si no se interviene a tiempo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El diagnóstico clínico se basa en una evaluación sistemática durante el **ABCDE del trauma**, seguida del **examen abdominal dirigido**.

3.1. Signos generales de trauma abdominal

- **Dolor abdominal o sensibilidad difusa.**
- **Distensión abdominal.**
- **Defensa muscular o rigidez (“abdomen en tabla”).**
- **Equimosis o hematomas en pared abdominal** (signo de cinturón de seguridad).
- **Signos de shock sin causa evidente externa.**

En trauma cerrado, los signos pueden ser **inicialmente leves**. La **inestabilidad hemodinámica sin otra causa evidente** debe hacer sospechar hemoperitoneo.

3.2. Signos específicos según órgano lesionado

Órgano	Características clínicas	Mecanismo
Bazo	Dolor en hipocondrio izquierdo, signo de Kehr (dolor referido al hombro izquierdo).	Trauma cerrado (accidente automovilístico).
Hígado	Dolor en hipocondrio derecho, shock rápido por hemorragia masiva.	Trauma cerrado o penetrante.
Intestino delgado / colon	Dolor difuso, signos peritoneales tardíos, aire libre subdiafragmático.	Trauma penetrante o desaceleración.
Diafragma	Disnea, ruidos intestinales en tórax, elevación hemidiafragmática en RX.	Trauma toracoabdominal izquierdo.
Retroperitoneo (páncreas, duodeno, riñón)	Dolor lumbar, hematoma en flanco, retardo diagnóstico.	Trauma cerrado por compresión o desaceleración.

3.3. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clínica principal
Shock hipovolémico por fractura pélvica	Hematuria o deformidad pélvica.
Hemotórax masivo	Disnea y matidez torácica.
Pancreatitis postraumática	Dolor epigástrico irradiado a dorso, amilasa elevada.

Peritonitis no traumática

Historia de enfermedad previa (úlcera, apendicitis, etc.).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes de urgencia inicial

- **Hemograma:** descenso progresivo de hematocrito indica sangrado activo.
- **Gasometría arterial:** acidosis metabólica refleja hipoperfusión.
- **Pruebas cruzadas para transfusión.**
- **Orina completa:** hematuria (sugiere trauma renal o vesical).

4.2. Ecografía FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma)

Herramienta fundamental en el **manejo inicial** del trauma abdominal.

Evalúa presencia de líquido libre en 4 zonas:

1. **Hepatorrenal (Morrison).**
2. **Esplenorrenal.**
3. **Pélvica (fondo de saco de Douglas).**
4. **Pericárdica.**

Interpretación:

- **FAST positivo + inestabilidad hemodinámica → laparotomía inmediata.**
- **FAST negativo → continuar evaluación o repetir en 15–30 min.**

4.3. TAC de abdomen y pelvis con contraste

Gold standard para pacientes **hemodinámicamente estables**.

Permite evaluar:

- Lesiones hepáticas y esplénicas (clasificación AAST).
- Laceraciones intestinales, neumoperitoneo, hematomas retroperitoneales.
- Lesión diafragmática o renal.

Indicaciones:

- Trauma abdominal cerrado con estabilidad hemodinámica.
 - FAST dudoso o discordante.
 - Sospecha de lesión retroperitoneal.
-

4.4. Lavado peritoneal diagnóstico (LPD)

Técnica antigua, usada cuando no hay FAST ni TAC disponibles.

Indicaciones positivas:

- 10 mL sangre franca al aspirar.
 - 100.000 eritrocitos/mm³ o >500 leucocitos/mm³.
 - Presencia de bilis, bacterias o alimentos.
-

5. Tratamiento (según Guías ATLS / MINSAL Chile 2022)

5.1. Principios generales

1. **Evaluar estabilidad hemodinámica.**
2. **Control de vía aérea y oxigenación.**
3. **Dos accesos venosos gruesos y reposición con cristaloideos tibios.**
4. **Transfusión sanguínea según necesidad.**

5. Profilaxis antibiótica de amplio espectro.
6. Monitoreo continuo y reevaluación frecuente.

5.2. Conducta según estabilidad hemodinámica

Estado del paciente	FAST/TAC	Conducta
Inestable + FAST positivo	No TAC	Laparotomía inmediata.
Estable + FAST positivo	TAC para definir extensión	Manejo conservador o cirugía según lesión.
Inestable + FAST negativo	Buscar otra causa de shock	TAC o reevaluar.
Estable + FAST negativo	Observación + repetir FAST	Alta vigilada o control clínico.

5.3. Manejo específico por órgano lesionado

Trauma esplénico

- **Manejo no operatorio:** en pacientes estables con lesión grado I–III (control clínico + TAC seriado).
 - **Cirugía (esplenectomía):** si sangrado persistente, shock o lesión grado IV–V.
 - **Profilaxis post-esplenectomía:** vacuna antineumocócica, H. influenzae y meningococo.
-

Trauma hepático

- **Manejo conservador:** si estable hemodinámicamente.
 - **Laparotomía:** si sangrado activo o rotura extensa.
 - Técnicas quirúrgicas: empaquetamiento hepático, sutura, resección parcial, taponamiento con hemostáticos.
-

Lesión intestinal

- **Laparotomía exploradora inmediata.**
 - **Cierre primario o resección con anastomosis** si perforación.
 - Si contaminación extensa → **colostomía o ileostomía derivativa.**
-

Lesión diafragmática

- Sospechar en traumas toracoabdominales izquierdos.
 - Confirmar con **TAC o laparoscopia.**
 - **Reparación quirúrgica directa** para prevenir hernia diafragmática tardía.
-

5.4. Profilaxis y cuidados complementarios

- **Antibióticos:** ceftriaxona + metronidazol (trauma penetrante o perforación intestinal).
 - **Profilaxis antitetánica.**
 - **Analgesia adecuada** y soporte respiratorio.
 - **Reevaluaciones seriadas** cada 1–2 horas en observación.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Lesión	Complicaciones	Pronóstico
Esplénica / hepática	Shock, hemorragia recurrente, absceso subfrénico.	Bueno si manejo precoz.
Intestinal	Peritonitis, sepsis, fístulas.	Depende de detección temprana.
Diafragmática	Hernia diafragmática, compromiso respiratorio.	Bueno si reparación oportuna.
General (trauma cerrado)	Falla multiorgánica por shock prolongado.	Mortalidad 10–30% si retraso diagnóstico.

Factores de mal pronóstico:

- Hipotensión prolongada.
- Politrauma con lesión craneal o torácica.
- Diagnóstico tardío.
- Edad avanzada y coagulopatía.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **FAST positivo + inestabilidad = laparotomía inmediata.**
2. **TAC con contraste = estándar en paciente estable.**
3. **El bazo es el órgano más lesionado en trauma cerrado.**

4. **Manejo no operatorio** viable en lesiones grado I–III con vigilancia.
 5. **Lesión intestinal = cirugía obligada.**
 6. **Trauma toracoabdominal izquierdo → sospechar ruptura diafragmática.**
 7. **Hemoperitoneo sin causa clara** = intervenir antes que observar.
-



Errores comunes

- Esperar resultados de laboratorio antes de decidir cirugía.
 - Repetir cristaloides en paciente inestable sin controlar foco hemorrágico.
 - No vacunar post-esplenectomía.
 - Subestimar dolor abdominal leve en politraumatizado.
 - No realizar FAST seriado.
 - Confundir contusión hepática con lesión activa.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Trauma abdominal** es causa importante de muerte prevenible.
2. **FAST** es el examen clave en el manejo inicial.
3. **FAST positivo + inestabilidad = laparotomía inmediata.**
4. **TAC con contraste** se reserva para pacientes estables.
5. **Bazo y hígado** son los órganos más frecuentemente lesionados.
6. **Manejo no operatorio** es posible si el paciente está estable.
7. **Lesión intestinal o diafragmática → cirugía obligada.**